

Chapitre 1

Panorama de la protection sociale

F. Candau (UPPA-TREE)

Six risques et un principe de solidarité

- Les politiques sociales prennent en charge une **baisse de revenus** ou une **hausse de dépenses** liées à des risques socio-économiques, sanitaires, ou à des événements du cycle de vie (chômage, maladie, vieillesse).
- Les comptes de la protection sociale en distinguent six catégories :
 - *santé* (maladie, invalidité, accidents du travail) ;
 - *vieillesse-survie* (retraites, minimum vieillesse, dépendance, réversion) ;
 - *maternité-famille* ;
 - *emploi* (indemnisation du chômage, préretraites, insertion) ;
 - *logement* ;
 - *pauvreté et exclusion sociale* (dont le RSA).
- La prise en charge repose sur un principe de **solidarité**, intragénérationnelle (les actifs en emploi financent les prestations chômage) ou intergénérationnelle (des actifs vers les retraités).

Périmètre, définition, plan

- Le périmètre est plus large que la seule Sécurité sociale (assurance chômage, aides sociales de l'État et des collectivités, mutuelles), et plus étroit que l'État providence (hors législation du travail, fiscalité, éducation).
- Une assurance est dite **sociale** lorsque la loi rend l'affiliation obligatoire et que son financement n'est pas lié au risque propre de chacun. Elle se distingue par là de l'assurance privée, facultative et tarifée selon le risque.
- Le chapitre présente d'abord les trois types de systèmes d'assurance et les deux logiques de couverture, puis le système français, ses branches et ses dépenses, et finit par la dynamique démographique.

Trois types de systèmes d'assurance

Il existe trois types de systèmes d'assurance.

- Un système **public et obligatoire** (France, assurance maladie de base).
- Un système **privé mais obligatoire**, la loi imposant de s'assurer auprès de compagnies en concurrence (Suisse, Pays-Bas).
- Un système **privé et facultatif**, que l'État soutient en exonérant d'impôt et de cotisations les contrats souscrits (États-Unis, couverture maladie des salariés).

Aucun pays ne relève d'un seul type. En France, l'assurance maladie de base est publique et obligatoire, la complémentaire santé des salariés est privée et obligatoire depuis 2013, et l'État la soutient en exonérant de cotisations sociales la part payée par l'employeur.

Le modèle contributif (Bismarck)

- Deux “système”.
- Dans un système Bismarkien, aussi dit contributif, la protection sociale est une assurance liée au travail, qui couvre ceux qui exercent une activité et cotisent, ainsi que leur famille. Le droit à la prestation naît de la cotisation.
- Son objet est de remplacer un revenu d’activité perdu => la prestation est proportionnelle au salaire antérieur. On fait perdurer les inégalités salariales.
- La prestation est un “salaire différé”, et non un transfert de la collectivité.
- La gestion revient à des caisses distinctes de l’État, où siègent employeurs et salariés (assurances sociales allemandes des années 1880, lois françaises de 1898-1930, Sécurité sociale de 1945).

Le modèle universel (Beveridge)

- Le modèle universel, dit beveridgien, fait de la protection sociale un droit attaché à la personne, indépendamment de son activité, et le droit à la prestation naît de l'appartenance à la collectivité.
- Son objet est de garantir à chacun un socle de ressources et l'accès aux soins, si bien que la prestation est **forfaitaire**, la même pour tous quel qu'ait été le revenu antérieur.
- Financement par l'impôt.
- La gestion revient à l'État (rapport Beveridge de 1942, pays nordiques).

Quatre dimensions pour situer un système

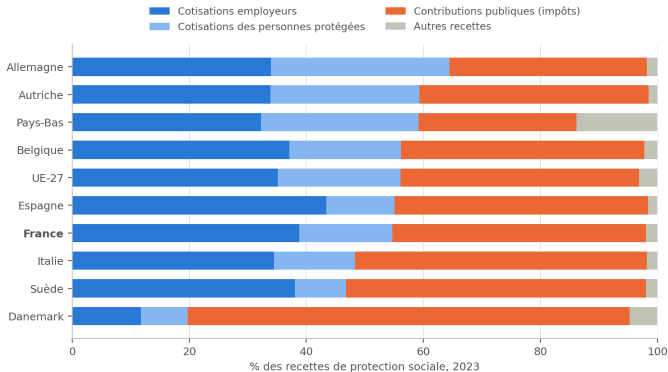
	Contributif (Bismarck)	Universel (Beveridge)
Accès aux droits	Emploi et cotisation	Résidence, citoyenneté
Prestations	Proportionnelles au salaire	Forfaitaires
Financement	Cotisations sur les salaires	Impôt
Gestion	Caisses, partenaires sociaux	Administration de l'État
Redistribution	Horizontale, entre risques	Verticale, entre revenus

- La frontière entre le contributif et le solidaire est **en partie conventionnelle**.

Aucun système réel n'est pur

- Les retraites et, dans certains pays, l'assurance chômage ont conservé des caractères contributifs, tandis que la santé, la famille et la lutte contre la pauvreté sont devenues presque partout universelles.
- Esping-Andersen (1990) classe les systèmes selon le degré auquel ils permettent de vivre sans dépendre du marché, et distingue trois régimes : **libéral** (États-Unis, prestations modestes, large place au marché), **social-démocrate** (pays nordiques, universel et fiscalisé), **conservateur-corporatiste** (Europe continentale, assurances professionnelles et gestion paritaire).
- La typologie a été critiquée pour son traitement de l'Europe du Sud, dont Ferrera (1996) fait un quatrième régime, et pour son silence sur la place des femmes et de la famille (Lewis, 1992).

La traduction financière



Cotisations : 20 % des recettes au Danemark, 64 % en Allemagne, 55 % en France. Source : Eurostat, ESSPROS.

Où se situe la France ?

- La France ne se range dans aucune des deux configurations. Partie du modèle contributif en 1945, elle a ouvert plusieurs de ses branches sur la résidence et fiscalisé une partie de son financement.
- Sa position dans la grille **n'est pas la même selon la branche** que l'on regarde, et il faut donc les prendre une à une.
- Le régime général, qui couvre les salariés du secteur privé, représente 40-45 % des prestations. Il est structuré en branches, chacune gérée par une caisse nationale devant assurer son équilibre financier (maladie, vieillesse, famille, accidents du travail, autonomie depuis 2020) ; le chômage et l'insertion sont gérés hors Sécurité sociale.

Le financement s'est déplacé

- Le financement a longtemps reposé sur des cotisations assises sur les salaires, qui ouvrent des droits.
- Depuis les années 1980-1990, les difficultés de financement ont conduit à recourir de façon croissante à l'impôt (CSG en 1991, CRDS en 1996, impôts et taxes affectés aux branches).
- La part des cotisations dans les recettes est descendue de **80 % en 1990 à 55 % en 2023**, et la France, partie d'un financement aussi contributif que celui de l'Allemagne, se situe désormais au niveau de la moyenne européenne.
- Cette transformation, et ses effets sur le coût du travail et l'emploi, font l'objet du chapitre 9.

Les branches selon la grille

Branche	Ouverture des droits	Règle principale	Financement
Maladie	Résidence depuis 2016	Tarif de convention, ticket modérateur	cotis. employeurs 38 %, CSG 23 %, impôts 29 %
Retraites	Cotisation, carrière	64 ans, 43 annuités, 25 meilleures années	cotis. employeurs 32 %, salariés 22 %, impôts 10 %, CSG 7 %
Chômage	6 mois sur 24	≈ 57 % du brut, 18 mois au plus avant 55 ans	contributions employeurs 60 %, CSG 38 %
Famille	Résidence, enfants	Dès le 2 ^e enfant, modulées depuis 2015	cotis. employeurs 63 %, CSG 24 %, impôts 10 %
Accidents du travail	Emploi salarié	Réparation forfaitaire, cotisation selon sinistralité	cotis. employeurs 92 %
Minima sociaux	Résidence, ressources	Prestation différentielle	impôt
Autonomie	Résidence, perte d'autonomie	Plan d'aide, participation selon revenu	CSG 89 %, impôts 11 %

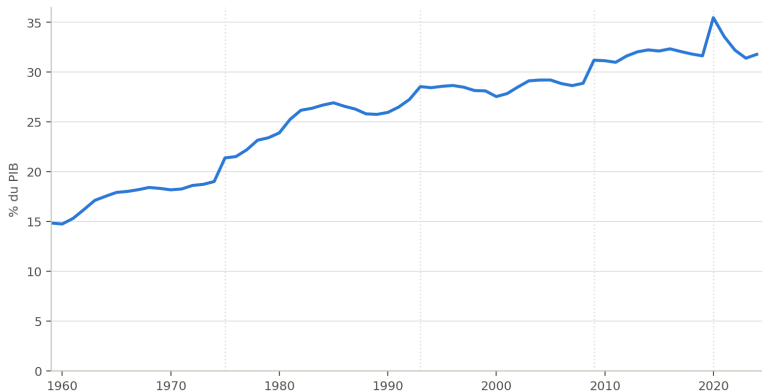
Un système hybride

- Les branches françaises dessinent un système double, une sphère d'assurance contributive pour les risques liés au travail et une sphère universelle et fiscalisée pour la maladie, la famille et la pauvreté, ce que Palier (2005) nomme la **dualisation**.
- Elbaum (2011) parle de système **hybride**, et Zemmour (2015) montre que le financement, proportionnel aux salaires au début des années 1990, est devenu progressif sous l'effet de la CSG et des allègements de cotisations sur les bas salaires.
- L'hybridation n'est pas propre à la France, mais elle y est marquée parce que le point de départ était plus contributif qu'ailleurs et le point d'arrivée plus fiscalisé.

Un tiers du PIB

- La part des prestations dans le PIB a plus que doublé, de **14,8 % en 1959** à **31,8 % en 2024**.
- Dans le plein emploi des années 1960, la famille, la vieillesse et la maladie sont les trois principaux postes. Après 1974, les allocations chômage montent, puis viennent le logement (APL) et, dans les années 1990, la lutte contre l'exclusion.
- L'indicateur bouge aussi par son dénominateur, le PIB se contractant en récession (−2,9 % en 2009, −7,8 % en 2020) au moment même où certaines dépenses augmentent. Chaque crise produit ainsi une hausse **par palier**, qui ne redescend ensuite que partiellement (pic de 35,5 % en 2020).

Prestations de protection sociale en % du PIB

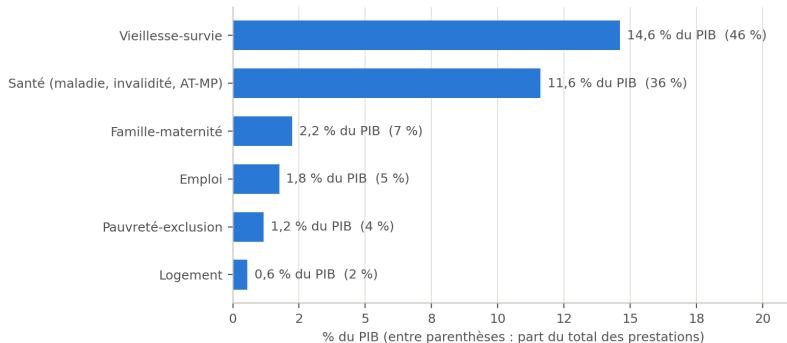


Traits verticaux : années de contraction du PIB (1975, 1993, 2009, 2020). Sources : DREES, comptes de la protection sociale ; INSEE.

Par habitant et par risque

- En 2024, les prestations représentent environ **13 600 euros par habitant**, dont 6 220 euros pour la seule vieillesse-survie. Ces moyennes sont à manier avec précaution, certains recevant peu et contribuant beaucoup, et inversement.
- La vieillesse-survie pèse **46 %** des prestations et la santé **36 %**, soit ensemble plus de 80 % du total.
- Les dépenses de santé sont poussées par les innovations médicales, par des prix des interventions et des médicaments de plus en plus élevés, et par le vieillissement, qui accroît les dépenses de fin de vie.

Répartition des prestations par risque

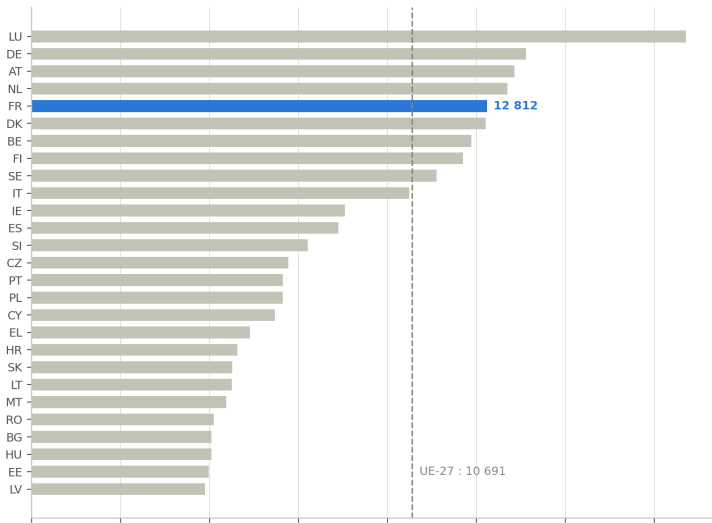


Source : Eurostat, ESSPROS.

Une exception française ?

- La France n'est pas le pays qui dépense le plus par habitant, 5^e sur 27 en 2023, derrière le Luxembourg, l'Allemagne et l'Autriche.
- Rapportées au PIB, en revanche, les dépenses françaises sont **les plus élevées de l'Union**, environ 6 points au-dessus de la moyenne de l'UE-27.
- Partout en Europe, ces dépenses, dominées par la vieillesse et la santé, ont un moteur commun, le vieillissement démographique.

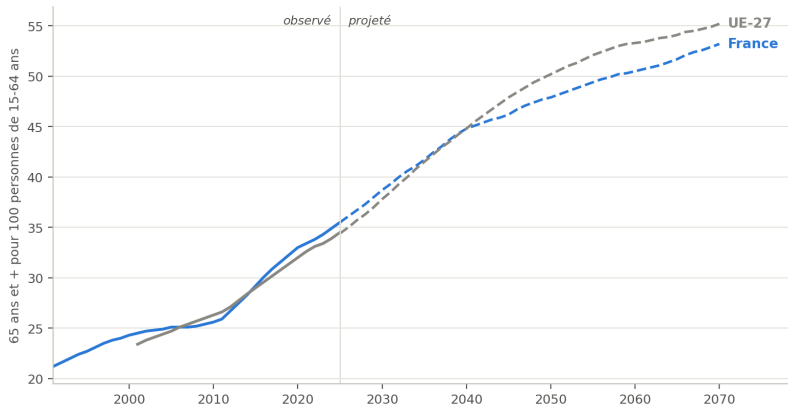
Dépenses de protection sociale par habitant en Europe



Le ratio de dépendance des personnes âgées

- Le ratio de dépendance des personnes âgées rapporte le nombre de personnes de 65 ans et plus à 100 personnes de 15 à 64 ans. Quand les prestations des inactifs âgés sont financées par les prélèvements sur les actifs, il mesure le nombre de personnes que chaque centaine d'actifs potentiels doit « porter ».
- Il est passé d'environ 21 au début des années 1990 à **36 aujourd'hui**, et les projections d'Eurostat le portent à 53 en 2070 dans le scénario central.
- Autrement dit, la France comptait environ cinq personnes d'âge actif par personne âgée en 1990, et elle en comptera moins de deux en 2070.

Ratio de dépendance des 65 ans et plus



Observé puis projeté (scénario central). Source : Eurostat.

Lire les projections

- Le vieillissement est général en Europe, et la France, grâce à une fécondité longtemps plus élevée, vieillit un peu moins vite en fin de période.
- À quinze ans, l'incertitude vient presque uniquement du solde migratoire ; à l'horizon 2070, la fécondité devient l'hypothèse la plus sensible, devant les migrations et l'espérance de vie.
- L'ordre de grandeur reste robuste, l'essentiel du vieillissement étant déjà inscrit dans la pyramide des âges. **Les personnes qui auront 65 ans en 2050 sont déjà nées.**
- Ce fait démographique structure tout le cours, des retraites (chapitre 4) à la santé et la dépendance (chapitre 5) et au financement de l'ensemble (chapitre 9).

Conclusion

- La protection sociale française ne correspond à aucun modèle pur. Née contributive, elle a ouvert l'accès aux droits par la résidence dans plusieurs branches et déplacé une partie de son financement vers l'impôt.
- Elle mobilise un tiers du PIB, dominée par la vieillesse et la santé, et le vieillissement démographique continuera d'en tirer les dépenses, la question du financement avec elles.
- Les chapitres suivants reprennent ces fils, l'histoire de cette construction d'abord, puis chaque branche avec ses tensions propres.

Les ordres de grandeur à retenir

- Prestations de protection sociale : environ **un tiers du PIB** (31,8 % en 2024), contre 14,8 % en 1959, soit environ **13 600 euros par habitant**.
- **Vieillesse-survie (46 %) et santé (36 %)** concentrent plus de 80 % des prestations.
- La France est **au sommet de l'UE en % du PIB**, mais 5^e par habitant.
- Part des cotisations dans les recettes : de **80 % en 1990 à 55 %** aujourd'hui.
- Ratio de dépendance des 65 ans et plus : d'environ **36 aujourd'hui à 53 en 2070**.